EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94311
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-07 12:09:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NELIDA GENOVEVA RODRIGUEZ MONTES			RUN	: 11.444.420-0
F.Nac	: 31-03-1969	Edad	: 55 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LOS NARANJOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 90307084		
Fecha Ingreso	: 2024-10-05	Fecha Egreso	: 2024-10-07 12:09:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15-NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E66-OBESIDAD. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

paciente cona ntec descrtios, consulta en SU el 04/10 por cuadro de 24 hrs de evolucion de disnea progresiva, sensacion febril, CEG, tos productiva, nauseas, vomitos, mialgia generalizada. Como antecedente refiere estar en tratamiento con ATB por cuadro de otitis.
A su ingreso en SU se describe disneico, taquipneica, se solicitan examenes de lab -> glicemia 110; crea 0,7, ac urico 4; Calcio 9,4; FA 123; bili tot/dir 1.2/0.32; GOT 43, GPT 47, GGT 105; TG 109; PCR 148,2; BUN 15, uremia 32; Na/K/Cl 135/4.2/105, INR 1,15; Hb14,1; Gb 17,6; VRS (-)
En vista de condiciones clinicas se decide ingreso para manejo y estudio
Durante estancia se inicia terapia ATB biasociada ceftriaxona/Azitromicina, con prsencia de peaks febriles intermitente durante inicio de hospitalizacion, en vista de lo anterior, se solicitan cultivos, sumado a terapia broncodilatadora y corticoesteroidal. Desde su ingreso sin requerimiento de O2 suplementario.

Paciente HDN estable, afebril desde hace 24 hrs, con buena tolernacia a alimentacion VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos, menos disneica en comparativa a dias previos, desde ingreso sin requerimiento de O2 suplementario

Examenes de lab -> glicemia 213, crea 0,7; lactato 1,3; PCR 87,5; uremia 54, He 60; Gb 9,5; Hb/HCto 12,4/37; plaq 233000; segment 75%; VHS 120; proca 0,61
HC/URC y CSB pendientes

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+), crepitantes finos bibasales
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente en su dia N° 3 hospitalzado, dia N°3 de ceftriaxona/Azitromicina, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con parametros inflamatorios en descenso, sin nuevo peak febril desde hace 24 hrs, se procedera a continuar hospitalizacion via HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°

2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 4 dias mas
4. Azitromizina 500 mg al dia VO por 2 dias mas
5. Prednisona 20 mg al dia VO por 2 dias
6. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC por 7 dias
7. Salbutamol 2 puff c/8hrs por AC por 7 dias
8. Losartan 50 mg c/12 hrs VO por 3 dias
9. Furosemida 40 mg al dia VO por 3 dias
10. Atorvastatina 40 mg al dia VO por 3 dias
11. Amlodipino 10 mg al dia VO por 3 dias
12. Carvedilol 6,25 mg c/12 hrs VO por 3 dias
13. KNT respiratoria una vez al dia
14. Examenes de control 11/10
15. Pendiente rescate de cultivos

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO